3.1.4.1. 부록 3. 임상영양관리 지침(요약)

담당부서	영양팀				
제정일		최종개정일	2025.03.	최종검토일	2025.03.

임상영양관리 지침(요약)

목적:

1. 영양팀에서 수행하는 임상영양업무를 표준화하여 환자에게 양질의 임상영양서비스를 제공한다.
2. 영양불량 고위험환자(영양불량위험환자)를 체계적으로 관리하여 영양불량 위험을 예방하고 적절한 영양중재 및 영양치료를 시행한다.
3. 환자의 영양문제를 파악하여 치료계획을 수립하고 이와 관련된 영양교육 및 상담을 제공한다.
4. 환자의 영양에 관한 모든 사항은 의료진과 공유하여, 치료 효과를 증대시키고자 한다.

기준:

1. JCI Standard 7th Edition COP.5, 5.1, PCI.9
2. 의료기관인증기준(4 주기) 진료전달체계와 평가 2.2.2, 환자진료 3.1.4, 3.1.5

지침:

1. 임상영양관리 지침

   1) 임상영양관리 지침이란 임상영양관리 지침서를 말한다.

   2) 영양팀에서 수행하는 임상영양업무를 표준화한 것으로 영양사가 환자의 임상영양관리를 시행하는데 필요한 표준화된 정보를 제공한다.

   3) 임상영양관리 지침은 의료진의 협의를 거쳐 영양관리위원회의 승인을 득하여야 한다.

   4) 임상영양관리 지침에는 질환에 따른 업무별 세부사항, 실무내용 및 상황 별 제공 교육자료, 집단교육 시행 시 직종별 주요 교육 내용 등 업무 수행 시 알아야 할 실무적인 정보 등을 포함하고 있다.

   4) 임상영양관리 지침은 최신 영양 지식을 반영하기 위해 주기적으로 검토 및 개정을 시행한다.

2. 임상영양관리 시행 절차

   1) 임상영양관리는 입원환자와 외래환자를 대상으로 시행한다.

   2) 임상영양관리는 영양초기평가, 재평가, 주치의의 의뢰에 의한 영양교육 및 상담, 영양집중지원을 통해 시행한다.

3. 입원환자 임상영양관리

   입원환자에 대한 임상영양관리는 다음 1)영양 초기평가, 2) 주치의 의뢰, 3) 재평가에 의한 3가지 경로를 통해 이루어진다.

1) 영양 초기평가

(1) 영양사는 환자가 입원한 후 24시간 이내에 "u-Severance – 영양검색" 시스템으로 영양 초기평가를 시행한다. 본관 응급단기병동의 환자가 병실로 전실 시에는 간호사의 입실 시행날짜를 기준으로 영양검색 대상에 포함된다. 단, 본관 및 심혈관의 일일입원실, 암병원단기관찰실, 본관 응급단기병동과 신생아실은 검색에서 제외한다.

① 성인

a. 영양 초기평가의 지표는 "체질량지수(BMI), 알부민, 최근 1달간 체중변화, 최근 1주일간 식사량 변화"로 한다.

② 소아

a. 주치의의 판단으로서 저위험군, 고위험군을 평가한다.

- 저위험군: 고위험군 이외의 환자
- 고위험군

: 임상적으로 영양평가가 반드시 필요하다고 판단되는 환자
경장영양 혹은 중심정맥영양을 하고 있거나 필요한 환자
성장곡선 기준으로 체중이 3백분위수 미만 혹은 97백분위수 이상인 환자. <개정 2018.9>
평소 체중에 비해 10%이상 의도하지 않은 체중감소가 있는 환자

③ 산과

a. 입원기록지 또는 외래기록지에 있는 임신 전 체중을 기준하여 체질량지수를 계산한다.

b. 체질량지수가 18.5 미만인 경우 또는 현재 체중이 50kg 미만이거나 90kg 이상인 경우 영양 고위험군으로 분류한다.

(2) 영양 초기평가결과는 "영양검색결과지"를 통해 의료진에게 고지한다.

(3) 고위험군 환자는 영양사에 의해 영양관리가 시행되고 '영양불량 고위험 환자 관리 기록지'에 기록한다.

(4) 영양사가 고위험군 환자 영양관리 시행 후, 추가 관리가 필요하다고 요청한 환자에 대해 의료진은 영양팀으로 협의진료를 의뢰한다.

2) 주치의 의뢰

– 환자 질병 상태 등을 고려하여 영양관리나 영양교육이 필요하다고 판단한 환자
– 영양집중지원이 필요하다고 판단된 환자

3) 재평가

(1) 대상

① 성인

a. 주치의로부터 영양평가에 대한 협의진료가 의뢰된 환자

b. 영양불량의 위험도가 높은 수술을 시행한 환자: 소화기암과 두경부암 수술 환자, 다발성 외상환자 등

c. 중환자실 입실환자

d. 진단명: 영양불량

e. 경장영양 또는 중심정맥영양을 하고 있거나 필요한 환자

f. 5일 이상 금식 유지 환자

② 소아

a. 주치의로부터 영양평가에 대한 협의진료가 의뢰된 환자

b. 경관유동식 처방 환자

4) 영양관리 방법 – 위의 1), 2), 3)에 해당하는 환자의 영양관리 방법은 다음과 같다.

(1) 담당영양사가 영양관리를 수행한다.

(2) 영양관리는 영양평가, 영양관리 계획 수립, 영양중재, 모니터링 및 평가의 과정으로 이루어진다.

① 영양평가

: 의무기록 검토 및 환자(또는 보호자)와의 면담, 생화학적 검사결과 조회, 필요한 경우 추가의 인체계측을 통하여 환자의 현재 영양 상태를 평가한다.

② 영양관리 계획 수립 및 영양중재

a. 환자의 영양적인 문제, 원인, 증상과 징후를 규명한다.

b. 환자의 영양상태 및 임상상태를 고려하여 영양요구량을 산정한다.

c. 영양문제의 원인을 제거 혹은 증상과 징후 경감을 목표로 영양중재 계획을 수립하고, 모니터링 지표 및 목표값을 설정한다.

③ 의무기록 작성

: 영양 평가내용 및 영양치료계획에 대해 의무기록을 작성하여 관련 의료진과 공유하며, 2)의 경우, 관련 사항은 세브란스병원 내규 [3.1.2.1. 협의진료체계]에 따른다.

④ 영양모니터링 및 평가

: 영양중재 목표 도달 여부를 평가하고, 도달하지 못하는 경우, 그 원인을 파악하여 추가 계획을 수립한다.

(3) 퇴원 후에도 영양적인 추적 관찰이 필요한 환자는 외래 방문 시 외래 담당 영양사와 상담할 수 있다.

2. 외래환자

1) 환자의 외래 진료 시 아래와 같은 환자에서 임상의사가 영양 검색을 실시할 수 있으며, 영양팀과 협

의한다.

2) 외래 환자의 영양 검색 기준은 다음과 같다.

(1) 말기신장질환/만성신장질환

(2) 혈당이 잘 조절되지 않는 당뇨병

(3) 이상지질혈증

(4) 영양불량

① 최근 1개월간 3kg 이상 혹은 3개월간 5kg이상의 체중감소

② 최근 1주간 평소 식사량의 1/2이하로 식사섭취량 감소

(5) 기타 담당 주치의가 필요하다고 판단하는 경우

3) 영양관리 방법

(1) 외래 영양상담 영양사는 협의진료 의뢰된 환자에 대한 영양관리를 수행한다.

(2) 영양관리는 영양평가, 영양관리 계획 수립, 영양중재, 모니터링 및 평가의 과정으로 이루어진다.

① 영양평가

: 의무기록 검토 및 환자(또는 보호자)와의 면담, 생화학적 검사결과 조회, 필요한 경우 추가의 인체계측을 통하여 환자의 현재 영양 상태를 평가한다.

② 영양관리 계획 수립 및 영양중재

a. 환자의 영양적인 문제, 원인, 증상과 징후를 규명한다.

b. 환자의 영양상태 및 임상상태를 고려하여 영양요구량을 산정한다.

c. 영양문제의 원인을 제거 혹은 증상과 징후 경감을 목표로 영양중재 계획을 수립하고, 모니터링 지표 및 목표값을 설정한다.

③ 의무기록 작성

: 영양 평가내용 및 영양 치료계획에 대해 "협의진료의뢰서"에 작성하여 관련 의료진과 공유하며, 관련 사항은 내규 [3.1.2.1. 협의진료체계]에 따른다.

④ 영양모니터링 및 평가

: 영양중재 목표 도달 여부를 평가하고, 도달하지 못하는 경우, 그 원인을 파악하여 추가 계획을 수립한다.